PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Plan Santé au Travail 2026-2030

14-11 DGAFP - Plan santé au travail dans la fonction publique 2026-2030 — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. La DGAFP pilote une feuille de route comprenant 4 axes, 14 objectifs, 22 actions et 49 sous-actions pour 5,80 millions d'agents.
2. L'objectif est d'atteindre 100 % d'employeurs publics disposant d'un document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour au 01/01/2028.
3. Le pilotage stratégique est assuré par la formation spécialisée n° 4 du Conseil commun de la fonction publique qui se réunit au moins 2 fois par an.

Plan Santé au Travail 2026-2030 : cadre et principes

Notion	À retenir
A. Origine et portée	Feuille de route de la **DGAFP** : **4 axes**, **14 objectifs**, **22 actions**, **49 sous-actions**. S'applique aux **5,80 millions d'agents publics**.
B. Ancrage réglementaire	Obligation de sécurité (**art. L. 4121-1 Code du travail**). Décrets **n° 82-453** (État) et **n° 85-603** (Territoriale). Directive **89/391/CEE**.
C. Principes de prévention	9 principes (**art. L. 4121-2 Code du travail**) : éviter, évaluer, combattre à la source, adapter le travail, évoluer techniquement, remplacer le dangereux, planifier, protéger collectivement, informer/former.

Axe 1 : Préserver la santé des agents face aux risques professionnels

Notion	À retenir
Risques psychosociaux	6 familles de facteurs (**accord-cadre 22/10/2013**, **rapport Gollac 2011**). Guide espaces de discussion et charte d'animation d'ici **2028**. Violences : **42 %** des atteintes liées au métier (privé **32 %**).
Genre et usure	Écart rémunération **9,8 %**. Outils d'évaluation genrée (**art. L. 4121-3 Code travail**) d'ici **2028**. Rendez-vous obligatoires par décret d'ici **2029**.
Accidents et réformes	Présomption d'imputabilité (**ordonnance 19/01/2017**). Modernisation conseils médicaux (**ordonnance 25/11/2020**). Doctrine partagée de l'imputabilité d'ici **2029**.
Risques émergents	Amiante : saisie **DTA-Thèque** d'ici **2027**. IA : règlement européen **2024/1689**. Climat : groupe de travail dès **novembre 2026** (FS4).

Consolidation et reconnaissance du réseau des acteurs de prévention

Notion	À retenir
Médecine de prévention	Révision des décrets de **1982** et **1985** d'ici **2028** ; cartographie nationale, délégations (**infirmiers, psychologues, ergonomes**) et référentiel de compétences pluridisciplinaire.
Corps d'inspection	**170 inspecteurs** (État), **600 agents** (territoriale). Révision des décrets **1982** et **1985** d'ici **2030** ; indépendance fonctionnelle via rattachement aux **Inspections générales ministérielles** d'ici **2028**.
Réseaux et comités	Guide national (**2029**) pour les **18 844 assistants** et **1 514 conseillers** (État) ; modules obligatoires dans les **écoles du service public** d'ici **2029**.

Indicateurs et seuils clés

15 %
Chute du nombre de médecins du travail en activité

5 738
Nombre de médecins du travail en 2012

4 853
Nombre de médecins du travail en 2025

1 / 14 800
Ratio inspecteur santé et sécurité / agents (Fonction publique de l'État)

1 / 12 291
Ratio contrôleur / salariés (Secteur privé)

3 mois
Délai pour la réponse motivée de l'employeur aux préconisations d'aménagement de poste

5 jours
Droit à la formation par mandat pour les représentants (décret n° 2020-1427)

Pilotage par la connaissance et évaluation scientifique

Notion	À retenir
Harmonisation outils	Objectif **100 %** d'employeurs avec **document unique** actualisé au **01/01/2028**. Conservation **40 ans** si ≥ **150 agents** (**art. L. 4121-3-1 du Code du travail**).
Centralisation données	Déploiement des **Bases de données sociales** (**2027**) avec indicateurs de sinistralité communs. Application numérique de suivi des **AT/MP** (**2028**) interopérable avec la **Banque nationale de données**.
Baromètres sociaux	Cartographie des baromètres (**2028**) et socle minimal d'indicateurs obligatoire dans les enquêtes ministérielles. Guide d'exploitation des résultats (**2027**) pour les directions et RH.

Échéances et outils clés

- **2027** : déploiement des **Bases de données sociales** (issues du rapport social unique) ; guide d'exploitation des baromètres sociaux.
- **2028** : modèles nationaux standardisés (document unique, registre santé et sécurité, registre de danger grave et imminent).
- **2028** : guide pratique et formation **MENTOR** (document unique, programme annuel de prévention) ; cartographie des baromètres existants.
- **2028** : application numérique de déclaration et suivi des **AT-MP** (État, avec le CISIRH).
- **01/01/2028** : document unique actualisé chez **100 %** des employeurs publics.

Gouvernance et articulation secteur privé

Notion	À retenir
Synergies secteur privé	Interface entre le plan privé (piloté par la **DGT**) et la fonction publique. Référents **DGAFP** au comité de pilotage national avant le **1er trimestre 2027**.
Pilotage concerté	Pilotage stratégique par la **formation spécialisée n° 4** du **Conseil commun de la fonction publique** (réunion min. **2 fois par an**).
Animation opérationnelle	Session annuelle mixte (formation spécialisée n° 4 + acteurs de la prévention) pour croiser analyses réglementaires et réalités du terrain.

Gouvernance : qui fait quoi

- Référents **DGAFP** : siéger au comité de pilotage national du plan privé avant le **1er trimestre 2027**.
- **DGAFP** : feuille de route des dispositions du **Code du travail** non transposées aux agents publics d'ici **fin 2027**.
- Groupe de travail permanent de la **FS4** : au moins **3 fois par an**, **bilans d'étape semestriels**, analyse des indicateurs.
- Comptes-rendus des sessions mixtes : partagés en **FS4** et diffusés aux **DRH ministérielles**.

Pièges et confusions

⚠ Confondre la durée de conservation du document unique (40 ans pour les structures de ≥ 150 agents) avec la validité du dossier technique amiante.

⚠ Croire que le ratio d'inspecteur santé et sécurité dans l'État est meilleur que dans le privé (1 pour 14 800 contre 1 pour 12 291).

⚠ Confondre l'assistant de prévention (premier niveau de proximité) avec le conseiller de prévention (coordination et conseil à l'autorité).

⚠ Penser que l'écart de rémunération femmes-hommes dans les ministères est de 44 % (c'est 9,8 % en 2025).

⚠ Confondre le registre de danger grave et imminent (signalements et procédures d'alerte) avec le registre de santé et de sécurité au travail (observations des agents).

Sigles et définitions

DGAFP	Direction interministérielle pilote la politique des ressources humaines et de la santé au travail dans la fonction publique.
Document unique d'évaluation des risques professionnels	Document légal obligatoire dans lequel l'employeur transcrit l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des agents.
Conseil commun de la fonction publique	Instance supérieure de dialogue social commune aux trois versants de la fonction publique.
Assistant de prévention	Agent public formant le premier niveau du réseau de prévention de proximité dans les administrations publiques.
Risques psychosociaux	Risques pour la santé physique, mentale et sociale engendrés par les conditions d'emploi, l'organisation du travail et les relations professionnelles.
Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique	Établissement public finançant l'aménagement des postes et l'accompagnement des agents en situation de handicap.

Auto-test

1. Quelle est la durée minimale de conservation du document unique pour les structures d'au moins 150 agents ?
2. Combien de jours de formation par mandat sont garantis aux membres des formations spécialisées des comités sociaux ?
3. Quelle est la date limite pour l'objectif de 100 % d'employeurs avec un document unique mis à jour ?
4. Quel est l'écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes fonctionnaires dans les ministères en 2025 ?
5. Quel est le nombre d'agents publics concernés par le plan santé au travail ?

Réponses : **1.** 40 ans · **2.** 5 jours · **3.** 01/01/2028 · **4.** 9,8 % · **5.** 5,80 millions

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.